

Punto ENARM -- Preguntas Pediatría

138 tarjetas de @PuntoENARM (feb-sep 2026). Enunciado = dato clave que pregunta el ENARM. [[Nota]] = patología existente en el vault.

Mar 2026 (8)

- **N504** (Tue Mar 17): EL TRATAMIENTO PRINCIPAL DE DIARREA AGUDA ES REHIDRATACION ORAL -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N505** (Tue Mar 17): LOS ANTIBIOTICOS EN DIARREA SE INDICAN EN CASOS SELECCIONADOS COMO DIARREA INVASIVA O PACIENTES DE RIESGO -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N507** (Wed Mar 18): EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA PARA C. DIFFICILE ES VANCOMICINA VO -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N581** (Tue Mar 31): EL APGAR SE EVALUA AL MINUTO Y A LOS 5 MINUTOS DE VIDA -- [[Escalas de Valoracio■n Neonatal]]
- **N582** (Tue Mar 31): EL APGAR EVALUA FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRACION, TONO, IRRITABILIDAD Y COLOR -- [[Escalas de Valoracio■n Neonatal]]
- **N583** (Tue Mar 31): UN APGAR ≤ 3 INDICA DEPRESION SEVERA -- [[Escalas de Valoracio■n Neonatal]]
- **N584** (Tue Mar 31): LA REANIMACION NEONATAL INICIA CON CALOR, SECADO Y ESTIMULACION -- [[Asfixia Neonatal]]
- **N585** (Tue Mar 31): SI EL RN NO RESPIRA SE INICIA VENTILACION CON PRESION POSITIVA -- [[Asfixia Neonatal]]

Apr 2026 (64)

- **N586** (Wed Apr 01): SI FC < 60 LPM SE INICIAN COMPRESIONES TORACICAS
- **N588** (Wed Apr 01): LA ICTERICIA FISIOLÓGICA APARECE DESPUES DE LAS 24 HORAS -- [[Si■ndrome Icte■rico Neonatal]]
- **N589** (Wed Apr 01): LA ICTERICIA ANTES DE 24 HORAS ES PATOLÓGICA -- [[Si■ndrome Icte■rico Neonatal]]
- **N590** (Wed Apr 01): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE ICTERICIA NEONATAL ES FISIOLÓGICA -- [[Síndrome Ictérico Neonatal]]
- **N591** (Mon Apr 06): LA BILIRRUBINA INDIRECTA ELEVADA ES LA MAS COMUN EN RN -- [[Si■ndrome Icte■rico Neonatal]]
- **N592** (Mon Apr 06): LA COMPLICACION DE HIPERBILIRRUBINEMIA ES KERNICTERUS -- [[Si■ndrome Icte■rico Neonatal]]
- **N593** (Mon Apr 06): EL TRATAMIENTO DE ICTERICIA ES FOTOTERAPIA -- [[Si■ndrome Icte■rico Neonatal]]
- **N594** (Mon Apr 06): LA EXANGUINOTRANSFUSION SE INDICA EN CASOS GRAVES
- **N595** (Mon Apr 06): EL TAMIZ METABOLICO DETECTA ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO -- [[El Neonato de Te■rmino Normal]]
- **N596** (Tue Apr 07): EL HIPOTIROIDISMO CONGENITO ES UNA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DETECTADAS EN TAMIZ -- [[patologias/Hipotiroidismo Conge■nito]]
- **N597** (Tue Apr 07): EL TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO CONGENITO ES LEVOTIROXINA -- [[Hipotiroidismo Congénito]]

- **N598** (Tue Apr 07): LA SEPSIS NEONATAL TEMPRANA OCURRE EN LAS PRIMERAS 72 HORAS -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N599** (Tue Apr 07): LA SEPSIS NEONATAL TARDIA OCURRE DESPUES DE LAS 72 HORAS -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N600** (Tue Apr 07): EL TRATAMIENTO EMPIRICO DE SEPSIS NEONATAL ES AMPICILINA MAS GENTAMICINA -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N601** (Tue Apr 07): EL PESO AL NACER NORMAL ES DE 2500 A 4000 GRAMOS -- [[El Neonato de Término Normal]]
- **N602** (Tue Apr 07): SE CONSIDERA BAJO PESO AL NACER <2500 GRAMOS
- **N604** (Tue Apr 07): EL RN PIERDE HASTA 10% DE SU PESO EN LOS PRIMEROS DIAS -- [[El Neonato de Término Normal]]
- **N605** (Tue Apr 07): EL RN RECUPERA SU PESO AL NACER A LOS 10-14 DIAS -- [[El Neonato de Término Normal]]
- **N606** (Wed Apr 08): LA FRECUENCIA CARDIACA NORMAL EN RN ES 120-160 LPM -- [[conceptos/El Neonato de Término Normal]]
- **N607** (Wed Apr 08): LA FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMAL EN RN ES 30-60 RPM
- **N608** (Wed Apr 08): LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SE RECOMIENDA HASTA LOS 6 MESES -- [[Lactancia Materna y Sucedaños de la Leche Materna]]
- **N609** (Wed Apr 08): EL REFLEJO DE SUCCION ESTA PRESENTE DESDE EL NACIMIENTO
- **N610** (Wed Apr 08): EL REFLEJO DE MORO DESAPARECE A LOS 4-6 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N611** (Wed Apr 08): EL REFLEJO DE PRENSION PALMAR DESAPARECE A LOS 3-4 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N612** (Wed Apr 08): EL CONTROL CEFALICO SE LOGRA A LOS 3 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N613** (Wed Apr 08): EL NIÑO SE SIENTA SIN APOYO A LOS 6 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N614** (Wed Apr 08): EL NIÑO CAMINA ALREDEDOR DE LOS 12 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N615** (Wed Apr 08): LA PRIMERA PALABRA SE DICE ALREDEDOR DE LOS 12 MESES -- [[Crecimiento y Desarrollo Infantil Normal]]
- **N621** (Thu Apr 09): LA INFECCION RESPIRATORIA AGUDA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MORBILIDAD EN NIÑOS
- **N622** (Thu Apr 09): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE RESFRIADO COMUN ES EL RINOVIRUS
- **N623** (Thu Apr 09): LA LARINGOTRAQUEITIS (CRUP) ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR VIRUS PARAINFLUENZA -- [[Laringotraqueobronquitis (Crup)]]
- **N624** (Thu Apr 09): EL CRUP SE MANIFIESTA CON TOS PERUNA Y ESTRIDOR INSPIRATORIO -- [[Laringotraqueobronquitis (Crup)]]
- **N625** (Thu Apr 09): EL TRATAMIENTO DEL CRUP LEVE ES DEXAMETASONA -- [[Laringotraqueobronquitis (Crup)]]
- **N626** (Fri Apr 10): LA EPIGLOTITIS ES CAUSADA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B -- [[patologias/Epiglotitis]]
- **N627** (Fri Apr 10): LA EPIGLOTITIS SE MANIFIESTA CON FIEBRE, DISFAGIA, SIALORREA Y POSICION EN TRIPODE -- [[Epiglotitis]]
- **N628** (Fri Apr 10): LA EPIGLOTITIS ES UNA URGENCIA QUE REQUIERE ASEGURAR VIA AEREA -- [[Epiglotitis]]
- **N629** (Fri Apr 10): LA BRONQUIOLITIS ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO -- [[Bronquiolitis]]
- **N630** (Fri Apr 10): LA BRONQUIOLITIS SE PRESENTA CON SIBILANCIAS Y DIFICULTAD RESPIRATORIA EN LACTANTES -- [[Bronquiolitis]]

- **N631** (Fri Apr 10): EL TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS ES DE SOPORTE (OXIGENO E HIDRATACION) -- [[Bronquiolitis]]
- **N632** (Fri Apr 10): LA NEUMONIA EN NIÑOS ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE -- [[Neumonía Adquirida en la Comunidad (Pediátrica)]]
- **N633** (Fri Apr 10): LA NEUMONIA BACTERIANA SE MANEJA CON ANTIBIOTICOS -- [[Neumonía Adquirida en la Comunidad (Pediátrica)]]
- **N634** (Fri Apr 10): LA TAQUIPNEA ES UN SIGNO CLAVE DE NEUMONIA EN PEDIATRIA -- [[Neumonía Adquirida en la Comunidad (Pediátrica)]]
- **N635** (Fri Apr 10): LA OTITIS MEDIA AGUDA ES CAUSADA FRECUENTEMENTE POR S. PNEUMONIAE -- [[Otitis Media Aguda]]
- **N636** (Mon Apr 13): EL TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA AGUDA ES AMOXICILINA -- [[patologías/Otitis Media Aguda]]
- **N637** (Mon Apr 13): LA FARINGOAMIGDALITIS BACTERIANA ES CAUSADA POR STREPTOCOCCUS PYOGENES -- [[Faringoamigdalitis Bacteriana]]
- **N638** (Mon Apr 13): EL TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS ES PENICILINA O AMOXICILINA -- [[Faringoamigdalitis Bacteriana]]
- **N639** (Mon Apr 13): LA CRISIS FEBRIL ES LA CONVULSION MAS FRECUENTE EN NIÑOS
- **N640** (Mon Apr 13): LAS CRISIS FEBRILES SIMPLES SON GENERALIZADAS Y DURAN <15 MINUTOS
- **N641** (Mon Apr 13): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE DIARREA AGUDA EN NIÑOS ES VIRAL (ROTAVIRUS) -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N642** (Mon Apr 13): EL SIGNO CLINICO MAS IMPORTANTE PARA EVALUAR DESHIDRATACION ES EL ESTADO GENERAL
- **N643** (Mon Apr 13): LA DESHIDRATACION LEVE CORRESPONDE A PERDIDA <5% DEL PESO CORPORAL -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N644** (Mon Apr 13): LA DESHIDRATACION MODERADA CORRESPONDE A PERDIDA DE 5-10% DEL PESO
- **N645** (Mon Apr 13): LA DESHIDRATACION GRAVE CORRESPONDE A PERDIDA >10% DEL PESO -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N646** (Tue Apr 14): EL TRATAMIENTO DE DESHIDRATACION LEVE-MODERADA ES VIDA SUERO ORAL -- [[patologías/Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N647** (Tue Apr 14): EL PLAN A DE REHIDRATACION ES EN CASA CON SOLUCION ORAL -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N648** (Tue Apr 14): EL PLAN B ES REHIDRATACION ORAL SUPERVISADA EN UNIDAD DE SALUD -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N649** (Tue Apr 14): EL PLAN C ES REHIDRATACION INTRAVENOSA -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N650** (Tue Apr 14): EL ZINC SE UTILIZA COMO COADYUVANTE EN DIARREA PEDIATRICA -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N651** (Wed Apr 15): LA PRINCIPAL COMPLICACION DE DIARREA ES LA DESHIDRATACION -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N661** (Thu Apr 16): EL CHOQUE EN PEDIATRIA SE CLASIFICA EN HIPOVOLEMICO, DISTRIBUTIVO, CARDIOGENICO Y OBSTRUCTIVO
- **N662** (Thu Apr 16): EL CHOQUE HIPOVOLEMICO ES EL MAS FRECUENTE EN NIÑOS
- **N663** (Thu Apr 16): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE CHOQUE HIPOVOLEMICO EN PEDIATRIA ES DESHIDRATACION
- **N665** (Thu Apr 16): EL BOLO INICIAL EN CHOQUE PEDIATRICO ES 20 ML/KG DE CRISTALOIDES -- [[Sepsis y Choque Séptico]]
- **N679** (Mon Apr 20): LA DIURESIS META EN NIÑOS ES >1 ML/KG/HORA

May 2026 (3)

- **N772** (Thu May 14): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE SINDROME NEFROTICO EN NIÑOS ES CAMBIOS MINIMOS
- **N775** (Thu May 14): EL COMPLEMENTO C3 DISMINUIDO ES CARACTERISTICO DE GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCOCICA
- **N791** (Fri May 22): LA LEUCEMIA AGUDA MAS FRECUENTE EN NIÑOS ES LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA

Jun 2026 (37)

- **N891** (Wed Jun 17): LA GASTROENTERITIS AGUDA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE DESHIDRATACIÓN EN PEDIATRÍA -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N893** (Wed Jun 17): EL PLAN A DE REHIDRATACIÓN SE REALIZA EN CASA CON VIDA SUERO ORAL -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N894** (Wed Jun 17): EL PLAN B DE REHIDRATACIÓN SE REALIZA EN LA UNIDAD DE SALUD CON SOLUCIÓN DE REHIDRATACIÓN ORAL -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N895** (Wed Jun 17): EL PLAN C DE REHIDRATACIÓN UTILIZA LÍQUIDOS INTRAVENOSOS -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N896** (Thu Jun 18): EL ROTAVIRUS ES UNA DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DIARREA AGUDA EN LACTANTES -- [[patologías/Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N897** (Thu Jun 18): LA LACTANCIA MATERNA DEBE CONTINUARSE DURANTE LOS EPISODIOS DE DIARREA -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N898** (Thu Jun 18): EL ZINC DISMINUYE LA DURACIÓN Y SEVERIDAD DE LA DIARREA AGUDA EN NIÑOS -- [[Enfermedad Diarreica Aguda]]
- **N901** (Sat Jun 20): LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES CAUSADA POR DEFICIENCIA DE SURFACTANTE -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N902** (Sat Jun 20): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES LA PREMATUREZ -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N903** (Sat Jun 20): EL ESTUDIO INICIAL EN ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N904** (Sat Jun 20): EL PATRÓN RADIOLÓGICO CLÁSICO DE ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES VIDRIO DESPULIDO CON BRONCOGRAMA AÉREO -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N905** (Sat Jun 20): EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA INCLUYE SURFACTANTE EXÓGENO -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N906** (Mon Jun 22): LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO SE DEBE A RETARDO EN LA REABSORCIÓN DEL LÍQUIDO PULMONAR FETAL -- [[patologías/Taquipnea Transitoria del Recién Nacido]]
- **N907** (Mon Jun 22): LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO ES MÁS FRECUENTE EN NACIDOS POR CESÁREA -- [[Taquipnea Transitoria del Recién Nacido]]
- **N908** (Mon Jun 22): EL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO OCURRE CON MAYOR FRECUENCIA EN RECIÉN NACIDOS DE TÉRMINO O POSTÉRMINO -- [[Síndrome de Aspiración de Meconio (SAM)]]
- **N909** (Mon Jun 22): EL MECONIO INACTIVA EL SURFACTANTE Y PRODUCE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA -- [[Síndrome de Aspiración de Meconio (SAM)]]
- **N910** (Mon Jun 22): LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO SE DEBE A FALLA EN LA DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA VASCULAR PULMONAR

- **N911** (Tue Jun 23): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE ES EL ECOCARDIOGRAMA
- **N912** (Tue Jun 23): EL ÓXIDO NÍTRICO INHALADO ES UN TRATAMIENTO IMPORTANTE EN HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO
- **N913** (Tue Jun 23): LA SEPSIS NEONATAL TEMPRANA OCURRE EN LAS PRIMERAS 72 HORAS DE VIDA -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N914** (Tue Jun 23): EL ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE SEPSIS NEONATAL TEMPRANA -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N915** (Tue Jun 23): ESCHERICHIA COLI ES UNA CAUSA FRECUENTE DE SEPSIS NEONATAL -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N916** (Thu Jun 25): EL TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA SEPSIS NEONATAL ES AMPICILINA MÁS GENTAMICINA -- [[patologías/Sepsis Neonatal]]
- **N917** (Thu Jun 25): LA MENINGITIS ES UNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA SEPSIS NEONATAL -- [[Sepsis Neonatal]]
- **N919** (Thu Jun 25): EL HERPES NEONATAL SE ASOCIA A INFECCIÓN MATERNA POR VIRUS HERPES SIMPLE -- [[Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N920** (Thu Jun 25): EL TRATAMIENTO DEL HERPES NEONATAL ES ACICLOVIR INTRAVENOSO -- [[Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N921** (Thu Jun 25): LA SÍFILIS CONGÉNITA SE TRANSMITE POR VÍA TRANSPLACENTARIA -- [[Sífilis (Treponema pallidum)]]
- **N923** (Thu Jun 25): LA SÍFILIS CONGÉNITA TEMPRANA PUEDE PRESENTARSE CON RINITIS SIFILÍTICA, HEPATOESPLENOMEGALIA Y LESIONES CUTÁNEAS -- [[Sífilis (Treponema pallidum)]]
- **N924** (Thu Jun 25): LA TRIADA DE HUTCHINSON INCLUYE DIENTES DE HUTCHINSON, QUERATITIS INTERSTICIAL Y SORDERA -- [[Sífilis (Treponema pallidum)]]
- **N925** (Thu Jun 25): EL TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA ES PENICILINA G -- [[Sífilis (Treponema pallidum)]]
- **N926** (Fri Jun 26): LA TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA CLÁSICAMENTE SE ASOCIA A CORIORRETINITIS, HIDROCEFALIA Y CALCIFICACIONES INTRACRANEALES -- [[patologías/Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N927** (Fri Jun 26): EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA ES TOXOPLASMA GONDII -- [[Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N928** (Fri Jun 26): LA RUBÉOLA CONGÉNITA SE ASOCIA A CATARATAS, CARDIOPATÍA Y SORDERA -- [[Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N929** (Fri Jun 26): EL CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO ES LA INFECCIÓN CONGÉNITA MÁS FRECUENTE -- [[Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N930** (Fri Jun 26): EL CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO SE ASOCIA A MICROCEFALIA, CALCIFICACIONES PERIVENTRICULARES E HIPOACUSIA -- [[Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N931** (Tue Jun 30): EL TRATAMIENTO DEL CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO GRAVE PUEDE INCLUIR GANCICLOVIR O VALGANCICLOVIR -- [[Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N935** (Tue Jun 30): LA PROFILAXIS ANTIRRETROVIRAL DISMINUYE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH -- [[Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)]]

Jul 2026 (24)

- **N936** (Wed Jul 01): LA HEPATITIS B PERINATAL SE PREVIENE CON VACUNA E INMUNOGLOBULINA AL RECIÉN NACIDO EXPUESTO -- [[patologías/Infecciones Congenitas y Perinatales (TORCH y otras)]]

- **N937** (Wed Jul 01): LA CONJUNTIVITIS GONOCÓCICA NEONATAL PUEDE CAUSAR PERFORACIÓN CORNEAL -- [[Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)]]
- **N938** (Wed Jul 01): LA PROFILAXIS OCULAR NEONATAL DISMINUYE EL RIESGO DE OFTALMÍA NEONATORUM
- **N939** (Wed Jul 01): LA CHLAMYDIA TRACHOMATIS ES UNA CAUSA FRECUENTE DE CONJUNTIVITIS Y NEUMONÍA NEONATAL -- [[Clamidiasis (Chlamydia trachomatis)]]
- **N940** (Wed Jul 01): LA NEUMONÍA POR CHLAMYDIA EN EL LACTANTE CURSA CLÁSICAMENTE SIN FIEBRE Y CON EOSINOFILIA
- **N1001** (Mon Jul 20): LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA MÁS FRECUENTE DEL PREMATURO -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1002** (Mon Jul 20): LA DEFICIENCIA DE SURFACTANTE ES LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1003** (Mon Jul 20): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA ES LA PREMATUREZ -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1004** (Mon Jul 20): EL SURFACTANTE ES PRODUCIDO POR LOS NEUMOCITOS TIPO II -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1005** (Mon Jul 20): EL CORTISOL FETAL ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE SURFACTANTE -- [[Cambios Fisiológicos del Embarazo]]
- **N1007** (Tue Jul 21): EL CUADRO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA INICIA EN LAS PRIMERAS HORAS DE VIDA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1008** (Tue Jul 21): EL QUEJIDO ESPIRATORIO ES UN DATO CLÁSICO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1009** (Tue Jul 21): EL ALETEO NASAL ES UN SIGNO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1010** (Tue Jul 21): LAS RETRACCIONES INTERCOSTALES SON DATOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NEONATAL
- **N1011** (Wed Jul 22): LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN EN LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1012** (Wed Jul 22): EL PATRÓN EN VIDRIO DESPULIDO CON BRONCOGRAMA AÉREO ES CARACTERÍSTICO DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1013** (Wed Jul 22): EL CPAP NASAL ES EL SOPORTE RESPIRATORIO INICIAL EN MUCHOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1014** (Wed Jul 22): EL SURFACTANTE EXÓGENO ES EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]
- **N1015** (Wed Jul 22): LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO ES MÁS FRECUENTE DESPUÉS DE CESÁREA SIN TRABAJO DE PARTO -- [[Taquipnea Transitoria del Recién Nacido]]
- **N1016** (Fri Jul 24): LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO SE DEBE AL RETARDO EN LA REABSORCIÓN DEL LÍQUIDO PULMONAR FETAL -- [[patologías/Taquipnea Transitoria del Recién Nacido]]
- **N1017** (Fri Jul 24): EL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO ES MÁS FRECUENTE EN RECIÉN NACIDOS DE TÉRMINO Y POSTÉRMINO -- [[Síndrome de Aspiración de Meconio (SAM)]]
- **N1018** (Fri Jul 24): EL MECONIO INACTIVA EL SURFACTANTE Y FAVORECE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA -- [[Síndrome de Aspiración de Meconio (SAM)]]
- **N1019** (Fri Jul 24): LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO SE DIAGNOSTICA MEDIANTE ECOCARDIOGRAMA
- **N1020** (Fri Jul 24): EL ÓXIDO NÍTRICO INHALADO ES UNO DE LOS PRINCIPALES TRATAMIENTOS DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO

Aug 2026 (2)

- **N1102** (Thu Aug 20): EL ESTUDIO INICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADENITIS MESENTÉRICA ES EL ULTRASONIDO ABDOMINAL
- **N1103** (Thu Aug 20): EL HALLAZGO ULTRASONOGRÁFICO DE LA ADENITIS MESENTÉRICA ES UN NÓDULO MESENTÉRICO HIPOECOICO